

## QCM Chir viscérale

### Partie 1

**Q1 : Signe pathognomonique d'une perforation gastrique ou colique ?**

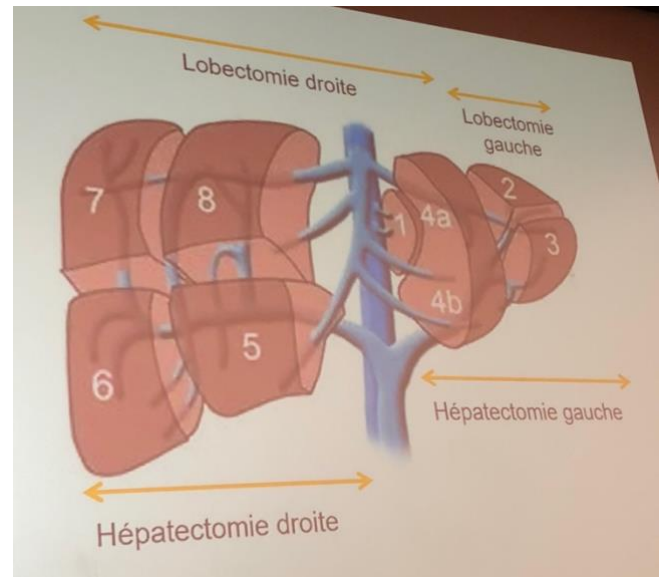
R : pneumopéritoine (air sous les coupes diaphragmatiques à la Rx debout)

Autres propositions (faux) : dlrs transfixiantes atroces, vomissements, signes de choc, arrêt du transit.

**Q2 : 2 ans après une colectomie D pour un cancer, patient de 65 ans présente une métastase du segment 3 du foie. Quelle opération ?**

R : Lobectomie G

Segments 2 et 3 forment lobe G. Le reste des segments forment le lobe D (pas du tout logique)



**Q3 : Suspicion d'hépatite fulminante. Test adéquat pour juger de la fonction du foie ?**

R : INR (Facteur V n'est pas dep de la vitamine K donc bon reflet de la fonction hépatique qui n'est pas influencé par un déficit en vitK)

Autres propositions (faux) : ASAT, plaquette (plaquette basse = reflet de l'hypertension portale, car la résistance augmente et la surpression en amont induit un hypersplénisme et une séquestration des plaquettes), Créatinine (utilisé dans certains scores pour quantifier la fonction hépatique ? mais pas la apparemment), Phosphatase alcaline (reflet cholestase, non spé)

**Q4 : 56 ans, dlrs hypochondre D depuis 24h, défense de l'hypochondre D, BMI 29, T 37.6, leuco à 13 G/l, tests hépatiques normaux, US montre stéatose hépatique modérée avec parois de la vésicule hyper-vasculaire à 5mm. Signe de Murphy radiologique. Diagnostic ?**

R : Cholécystite aiguë —> traitement par ATB et CKK (quand ? 2 stratégies, la + répandue : CKK en subaiguë le lendemain ou surlendemain, autre possibilité c'est à 6 semaines).

**Q5 : 54 ans, lésion du segment 4 du foie de 3 cm, alpha-foetoprotéine à 432 umol/l (N < 10, marqueur tumoral assez spé du CHC, aussi un peu testiculaire). Anamnèse d'infection au HBV. Diagnostic ?**

R : CHC

Autres possibilités (faux) : cirrhose, adénome, cholangiocarcinome, métastase de ca colo-rectal

**Q6 : Signe de pression veineuse portale élevée chez patient avec cirrhose ?**

R : thrombopénie

Turgescence jugulaire = signe d'hypertension systémique.

**Q7 : 76 ans, douleurs de l'hypocondre D, ictère, fièvre (= triade de Charcot). Diagnostic ?**

R : cholangite

Autres propositions (faux) : Migration de calcul ne fait pas fièvre, cholécystite ne fait pas d'ictère

**Q7b : intervention la + adéquate ?**

R : ERCP (ATB<sup>1</sup> iv avant, on regarde la réponse et on fait l'ERCP le lendemain). Laparoscopie dans un 2<sup>e</sup> temps pour enlever la VB.

Drainage per-cutané : peut être fait si on a pas d'accès au duodénum, par ex patient qui ont eu une chir bypass.

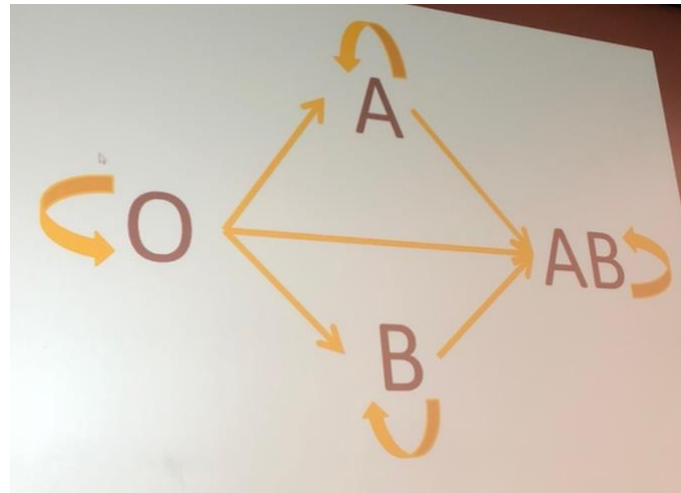
**Q8 : 25 ans, IR terminale, groupe sanguin B. Meilleur traitement ?**

R : transplantation d'un rein reçu d'une amie de 45 ans de groupe sanguin O

Autres propositions (faux) : dialyse péritonéale, transplantation d'un rein reçu d'un donneur en mort cérébrale de 40 ans de groupe sanguin B (c'est mieux un donneur vivant), transplantation d'un rein reçu de son mari de 35 ans de groupe sanguin A (incompatibilité ABO), hémodialyse.

O : donneur universel

AB : receveur universel



**Q9 : 65 ans, coloscopie dans le cadre d'un bilan pour anémie spoliative. Masse sténosante du sigmoïde non franchissable par l'endoscope, biopsie = ADK. Prochaine étape ?**

R : CT scan thoraco-abdo

Autres propositions (faux) : sigmoïdectomie laparoscopique, US abdo, radiothérapie néoadjuvante, Hartman.

**Q10 : 25 ans, BMI 41, blessure abdo par pic à glace depuis 4h<sup>2</sup> (= risque de perforation intestinale, peut ne pas faire de dlrs et ensuite des complications sévères). Plaie sus ombilicale, 1cm de large, difficilement examinable en profondeur. Patient normocarde, normotendu, eupnéique. Bilan sanguin sp. PEC ?**

R : CT scan abdo

Autres propositions : laparotomie, exploration de la plaie sous anesthésie locale (non à cause du BMI), suture de plaie par des points séparés, rx de l'abdomen sans préparation.

Si hémodynamiquement instable —> chir en urgence sans passer par le scan (mais on peut faire un FAST).

---

<sup>1</sup> Rocéphine-Flagyl

<sup>2</sup> On est sensé le laisser dedans

**Q11 : 45 ans, douleurs en coup de poignard de la région épigastrique, persistante depuis 4h. Fumeur, douleurs du haut abdomen depuis plusieurs semaines. US abdo récemment était sp (notamment la VB). Abdomen aiguë, péritonisme du haut abdomen, absence de bruit. Quelle technique d'imagerie semble la plus utile ?**

R : Rx du thorax de face debout à la recherche d'un pneumopéritoine (CT aussi possible)

Diagnostic : ulcère perforé (possible aussi migration lithiasique mais l'US était sp), apparemment ulcère chronique.

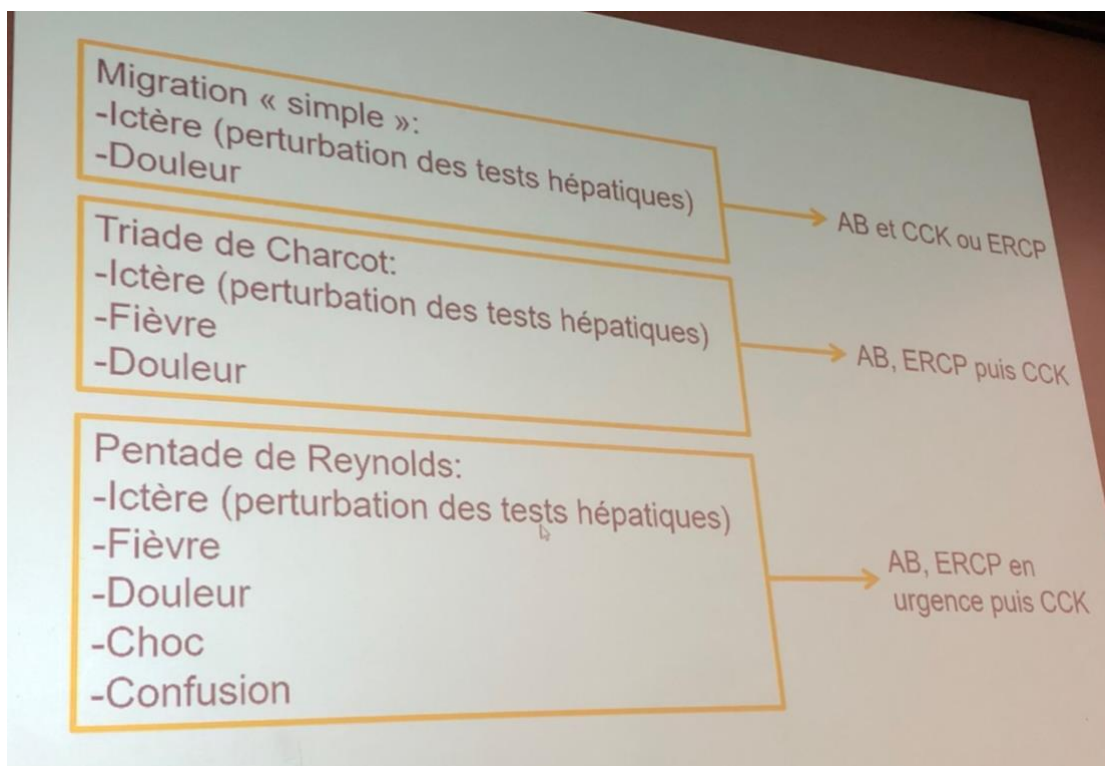
Transit baryté : permet de voir problème structurel, comme sténose

**Q12 : 63 ans, douleurs de l'hypochondre D, état général diminué, T 38.3, douleur de l'hypochondre D sans défense, présence d'un ictère. Labo : bili 83, ALAT 120, PA 320, Leuco 14, neutrophiles 85%. US montre lithiasie vésiculaire, et dilatation des voies biliaires intra et extrahépatique. Démarche ?**

R : ATB, ERCP avec papillotomie et cholécystectomie laparoscopique ultérieure.

Cholangite : toujours lorsqu'il y a un obstacle à l'écoulement de la bile, si douleurs c'est le + souvent un calcul, mais il peut y avoir aussi des cholangites sur tumeur, qui sont souvent moins douloureux.

Migration simple : ATB en prophylaxie, car risque d'infection sur l'obstruction



**Q13 : 18 ans, collision avec co-équipier, fracture de la 10<sup>e</sup> cote G. 14 jours + tard, il présente un collapsus à son poste de travail, hospitalisé en état de choc. Cause la + probable :**

R : rupture de rate (en 2 temps : d'abord traumatisme fait hématome sous-capsulaire de la rate, puis il se rompt, sans forcément un autre traumatisme, et conduit à un choc hypovolémique)

Autres propositions : pneumothorax sous tension (se dev rapidement après un traumatisme).

Si mécanisme compatible avec rupture de la rate : CT ou US et à garder sous surveillance.

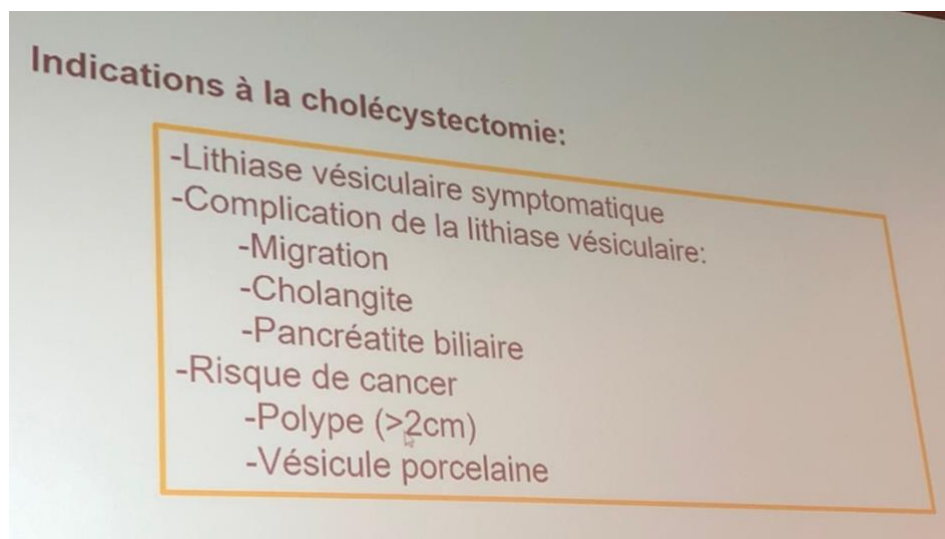
**Q14 : 52 ans, japonais, douleurs épigastriques depuis plrs mois, accrues par la prise de nourriture, sensation de réplétion gastrique précoce et vomissements postprandiaux depuis 2 jours. Perte pondérale de 5kg en 1 mois. Quel examen est le + susceptible de poser le diagnostic ?**

R : OGD

**Q15 : 40 ans, BSH, bilan lors d'un check-up montre de multiples calculs dans la VB = lithiase vésiculaire asymptomatique. PEC ?**

R : Absence de traitement (sauf si vésicule porcelaine, polypes dans la VB, ev. bypass gastrique), les diabétiques sont + à risque mais n'indique pas la CKK élective

Autres propositions : CKK laparoscopique, suivi par US dans une année, lithotripsie, prescription d'acide ursodésodicholine (permet de diminuer la formation de calcul)



**Q16 : 68 ans, ictère nu et signe de Courvoisier (= dilatation de la VB et ictère, indique obstruction sur le canal cystique, souvent dans le cadre d'une néoplasie). Diagnostic ?**

R : Cancer du pancréas

Cholangite : non car pas de fièvre, ni de douleurs

**Q17 : 40 ans, méléna. Hb 123, urée 24, créat 60. Intervention ?**

R : gastroscopie

Dissociation entre l'urée et la créat : une augmentation de l'urée sans augmentation de la créatinine (augmentation du rapport urée/créat) chez un patient anémié est en faveur d'une hémorragie digestive haute. En effet la digestion du sang libère beaucoup d'acides aminés responsable d'une hausse de l'urée d'origine extra-rénale (créatinine stable).

**Q18 : CKK pour lithiase symptomatique, difficultés pendant la chir —> convertit en laparotomie. Vous avez coupé le canal hépatique D (assez haut placé). Que faites-vous ?**

R : mise en place de drains et transfert à un centre spécialisé

Facteurs de mauvais pronostic pour la réparation des plaies de la voie biliaire (fuites, sténose...), facteur maj c'est que le chir répare lui-même.

**Q19 : test le + sensible pour détecter un RGO ?**

R : pH-métrie de 24h

Autres propositions (faux) : transit oeso-gastrique au baryum, manométrie (pour exclure une anomalie de contraction de l'œsophage, car du coup la chir ne serait pas indiqué), transit oeso-gastrique à la gastrographie (pour bien visualiser l'anatomie, s'il y a une hernie, son positionnement...), OGD.

**Q20 : 75 ans, AINS pour arthrite, se présente avec un péritonisme abdo et un pneumopéritoine visible au CT. Symptômes sont apparus il y a 6h, signes vitaux stables après 1L de NaCl. PEC ?**  
R : IPP, ATB, et laparoscopie d'emblée

Autres : IPP, ATB et... laparotomie (pas nécessaire), OGD (pousse encore plus de l'air et du liquide gastrique par le trou, et c'est pas thérapeutique).

**Q21 : 55 ans, cirrhose sur hépatite C, bili 100 (très haut), créat 110 (un peu élevé), INR 1.9 (très haut). US montre une masse de 5 cm avec prise de contraste précoce et wash-out tardif (signe typique de CHC) dans le foie D. Alpha-fœtoprotéine est à 80ug/l. Traitement ?**  
R : Transplantation du foie (double indication : cirrhose décompensée et CHC<sup>3</sup>)

Traitement ? foie déjà malade, probablement un Child C, pas super d'enlever en plus un bout de foie. Chimiothérapie par 5FU (inutile... ?), radiofréquence c'est pour des lésions de max 2-3 cm. Plus la tumeur est grosse, + risque de récurrence du CHC.

---

<sup>3</sup> 1 tumeur de < 5cm, ou 3 tumeurs de ... ?

## Partie 2

**Q2 : quelle intervention chir est indiquée en cas de découverte d'un ADK du colon chez un patient avec RCUH ?**

- A. Procto-colectomie avec poche en J iléo-anale
- B. Résection sigmoïdienne
- C. Résection transanale
- D. Hémicolectomie G
- E. Amputation abdomino-périnéale du rectum

R : A

Particularité de PEC du RCUH, car augmentation du risque de cancer sur tout le colon et peut-être qu'il y a des cancers ailleurs qu'on ne voit pas. Certains cas spé on peut préserver le rectum.

Pour maladie de Crohn on peut faire des résections segmentaires.

**Q3 : Quelle intervention chir est indiquée en cas d'adénome villeux du rectum situé à 4-6cm de la marge anale ?**

- A. Procto-colectomie
- B. Résection sigmoïdienne
- C. Résection trans-anale
- D. Rx thérapie locale
- E. Amputation abdomino-périnéale du rectum

R : C

Polype bénin, donc chir conservatrice, dans certains cas peut être fait directement par le gastro-entérologue.

**Q4 : 45 ans, douleurs en coup de poignard de la région épigastrique, persistantes depuis 4h. Fumeur, présente occasionnellement des douleurs du haut abdomen depuis plusieurs semaines. US abdo récent ne montre pas de cholélithiase. Abdomen aiguë avec péritonisme et absence de bruit. Imagerie indiquée :**

- A. Ct scan injecté + produit de contraste (gastrografine)
- B. Rx thorax de face couché (aucun intérêt car ne permet pas de voir pneumopéritoine, qui est le seul truc qu'on pourrait chercher sur une Rx)
- C. Rx thorax de face debout
- D. Transit baryté
- E. Répétition d'un US

R : A

On pense à un ulcère gastrique perforée, mais dans le DD il y a aussi une diverticulite perforée, scan peut nous montrer les 2 en même temps.

**Q5 : 89 ans, hospitalisé suite à une chute qui a entraîné une fracture de hanche. Atcd : IC, IRC et carence en vit B12, cachexie importante (56kg pour 180cm), perdu 6kg en 3 mois. Anémie normocytaire normochrome à 10.8 g/dL. Il est opéré de sa hanche. Quelle est l'action la + appropriée concernant ce patient ?**

- A. Gastroskopie/colonoscopie
- B. Alimentation parentérale
- C. Introduire des suppléments oraux
- D. Prescrire du fer PO (pour ça il faut doser le fer avant)

E. Prescrire des suppléments de polyvitamines

R : A

Anémie normo normo avec perte pondérale doit faire penser à un cancer. L'âge n'est pas un critère pour ne pas opérer les gens d'un cancer du colon. L'anémie pourrait aussi être liée à l'IRC.

Ca du colon, 2<sup>e</sup> cancer chez la femme 3<sup>e</sup> chez l'homme. On peut éviter 1 décès sur 100 patients dépistés par coloscopie.

On doit pas payer la franchise pour les examens de dépistage juste la quote-part (la colo et le sang occulte dans les selles, 100.- pour la colo et 4.- pour le FID). A Genève, on a un programme de dépistage depuis 4 ans, premier en Suisse.

**Q6 : 60 ans, ADK du bas rectum lors d'un ct scan abdo. Quel est le meilleur traitement ? En sachant qu'il n'y a pas de lésion 2<sup>nd</sup> à distance et que l'US endorectal montre une tumeur circonférentielle uT3N1 avec une marge circonférentielle <1mm.**

- A. Proctectomie
- B. Résection antérieure basse suivi d'une chimiothérapie à base de 5-FU
- C. Mise en place d'une prothèse métallique endorectale (non jamais, super désagréable car ça appuie sur les sphincters et donne l'impression de faux besoins tout le temps).
- D. Rx avec chimio-sensibilisation néo-adjuvante puis chir
- E. Chimiothérapie palliative

R : D

Si la marge circonférentielle est envahie il faut un tt néoadjuvant (= avant une chir), permet de gagner de la distance sur la marge circonférentielle et d'augmenter les chances de guérison.

Mésorectum = gaine de graisse avec gg, pas très épais, il faut une marge d'au moins 1mm pour ne pas avoir de risque qu'il y aille encore de la tumeur.

Taux de guérison après chir du rectum = 80-90%.

**Q7 : Bilan d'un cancer du rectum ?**

- A. Colo et biopsie
- B. CT thoraco-abdo
- C. IRM pelvienne
- D. Rectoscopie rigide
- E. Toutes ces réponses sont correctes

R : E

Coloscopie : permet de donner le diagn par la biopsie et s'assurer qu'il n'y a pas de lésion synchrone ailleurs (dans 20% des cas), donc il faut bien être allé jusqu'au bout de l'exploration du colon.

**Q8 : 72 ans, 2 pontages aorto-coronarien et aorto-bifémoral, bypass fémoro-poplité G, amputation d'orteil à D et IRC. Hématochézie importante et instabilité hémodynamique. Diagn le + probable ?**

- A. Hémorragie sur colite ischémique
- B. Varices œsophagiennes rompues
- C. Anévrisme rompu de l'artère gastro-duodénale
- D. Fistule aorto-duodénale
- E. Ischémie mésentérique

R : A

Patiente polyvasculaire, pas de péritonisme ni de douleurs.

Ischémie mésentérique : dlrs très violentes, non soulagée par MO, urgence —> scan.

Fistule et anévrisme rompu : serait probablement déjà mort.

Ici PEC c'est de faire un scan pour s'assurer si elle ne saigne pas quelque part.

**Q9 : 65 ans, douleurs du bas ventre, défense en FIG. GB 16'000, scan montre infiltration de la graisse autour du colon sigmoïde, sans air ou liquide libre. PEC ?**

- A. Laparotomie avec colostomie latérale (sans résection)
- B. Préparation colique en vue d'une colo
- C. Laparotomie avec résection sigmoïdienne
- D. Opération selon Hartmann (dans l'aiguë)
- E. TT conservateur avec ATB

R : E

Faire une colo après résolution (6 semaines ? car augmentation du risque de cancer, spécialement si abcès ou péritonite). C'est le scan qui permet de prendre la décision sur l'opération (péritonite, phlegmon, abcès, air libre), pas le labo.

Classification de Hinchey :

- Ia
- Ib : abcès, nécessite ATB.
- II
- III (péritonite purulente) ou IV (péritonite fécale avec selles dans le ventre) : on opère, on fait souvent pas la distinction entre les 2 au scan.

La taille de l'abcès influence la prise en charge, si < 4cm —> drainage percutané (sauf si inatteignable).

**Q10 : 80 ans, troubles du transit dans le cadre d'un Parkinson, présence de manière aiguë la présence d'une masse sortant de l'anus de la couleur d'une aubergine et douloureuse. Apparue après un effort de défécation.**

- A. Tumeur
- B. Prolapsus rectal incarcerated
- C. Hémorroïde
- D. Normal rien à faire
- E. Fissure anale

R : B

Chez les jeunes, FR = parachutiste et anorexie

Si couleur aubergine = urgence, à réduire le + vite possible. Parfois il y a un œdème, donc pour réduire l'œdème on peut mettre du sucre en poudre dessus (effet osmotique).

Si impossible de réduire, opération d'Altemeier en urgence.

TT à long terme :

- Rectopexie : pour remonter le rectum et l'accrocher au promontoire
- Opération de Delorme ?
- Altemeier : on coupe ce qui dépasse

Il faut essayer de réduire à la main, si ça marche pas mettre du sucre en poudre et réessayer, si ça marche toujours pas appeler le chir.



**Q11 : 82 ans, douleurs en colique ayant débuté la nuit passée, vomit 2x, afébrile, leuco à 12'500, CRP à 12. Scanner met en évidence une intussusception iléo-colique. Qu'est ce qui est vrai ?**

- A. Résection colique est indiquée
- B. On peut espérer un traitement définitif avec un simple lavement
- C. Coloscopie sera probablement normale et permettra le tt de l'intussusception dans le même temps
- D. Environ la moitié des patients présentant un tableau similaire guérissent spontanément
- E. Il ne s'agit jamais d'une tumeur à cet âge

R : A

Jusqu'à preuve du contraire, une invagination iléo-colique est liée à une tumeur chez les patients âgés (≠ enfants). Souvent on a besoin de faire la résection pour faire le diagn. Réponse B est juste chez un enfant mais faux chez un adulte. La colo va pas permettre de dés-invaginer et elle sera probablement pas normale. La D est juste pour les enfants.

**Q12 : 26 ans, crampes abdo diffuses récidivantes, masse abdo palpable, hyperpigmentation des lèvres, des paumes et des plantes de pied. A l'anamnèse familiale son père a eu une excision de polype plusieurs années auparavant. Diagn ?**

- A. Polypose familiale avec dégénérescence maligne
- B. Syndrome de Gardner avec intussusception
- C. Syndrome de Peutz-Jeghers avec intussusception
- D. Maladie de Crohn symptomatique
- E. Gastrinome

R : C

Peutz-Jeghers : hamartomes bénins le long du tractus dig et vont faire une invagination la dessus. Les gens qui ont des mélanomes peuvent aussi faire des invaginations, ainsi que toutes les carcinoses. Polypose familiale : on enlève le colon super jeune ?

**Q13 : 29 ans, APP 4 jours auparavant, le pathologue vous signale la présence d'une tumeur carcinoïde de 2.5cm au sein de l'appendice, réséqué en totalité. Le CT ne montre pas de lésion ailleurs. PEC ?**

- A. Colectomie D est indiquée
- B. Étant donné la taille, un syndrome carcinoïde est probable
- C. Localisation la plus fréquente des carcinoïdes est l'APP
- D. Seule une surveillance par colo tous les 2 ans est nécessaire (non pas trop utile car la dissémination de ces tumeurs se fait en hématogène ou lymphatique, pas endo-luminal)
- E. Complément de résection ne doit être effectué qu'en cas de résection incomplète ou de syndrome carcinoïde

R : A

Syndrome carcinoïde : flush, érythémateux, diarrhées. Quand maladie avancée, charge neuro-endocrine avancée.

NET carcinoïdes :

- Taille de la tumeur > 2 cm
- Invasion lymphatique
- Envahissement gg
- Résection en marge positive
- Pléomorphisme cell avec haut index mitotique

Actuellement < 2cm —> pas de résection complémentaire  
>2cm —> résection complémentaire

**Q14 : Femme de 28 ans, douleurs en FID d'apparition rapide qui persiste, subfébrile, leuco 13'000, nausée. Douleurs en FID avec contracture musculaire et effet de masse. Image en cocarde à l'US. Diagn ?**

- A. Appendicite aiguë
- B. ADK caecal
- C. Hématome du muscle grand D
- D. Torsion d'un kyste ovarien
- E. Cholécystite

R : A

PEC si suspicion APP : US, si pas de réponse —> CT low dose, si toujours pas de réponse scanner haute dose ou exploration laparo.

**Q15 : 30 ans, douleur épigastrique de survenue soudaine, il prend des AINS depuis 5j pour une douleur dorsale. Diagn ?**

- A. Varices œsophagiennes
- B. Infarctus
- C. Cholécystite
- D. Ulcère gastrique
- E. IRA

R : D

**Q16 : 55 ans, alcoolique chronique, hématomène importante de survenue soudaine. Connu pour une hépatopathie d'origine OH et viral. Diagn ?**

- A. Sg de varices œsophagiennes
- B. Sy de Mallory-Weiss
- C. Gastrite
- D. Ulcère gastrique
- E. Ulcère duodénal

R : A